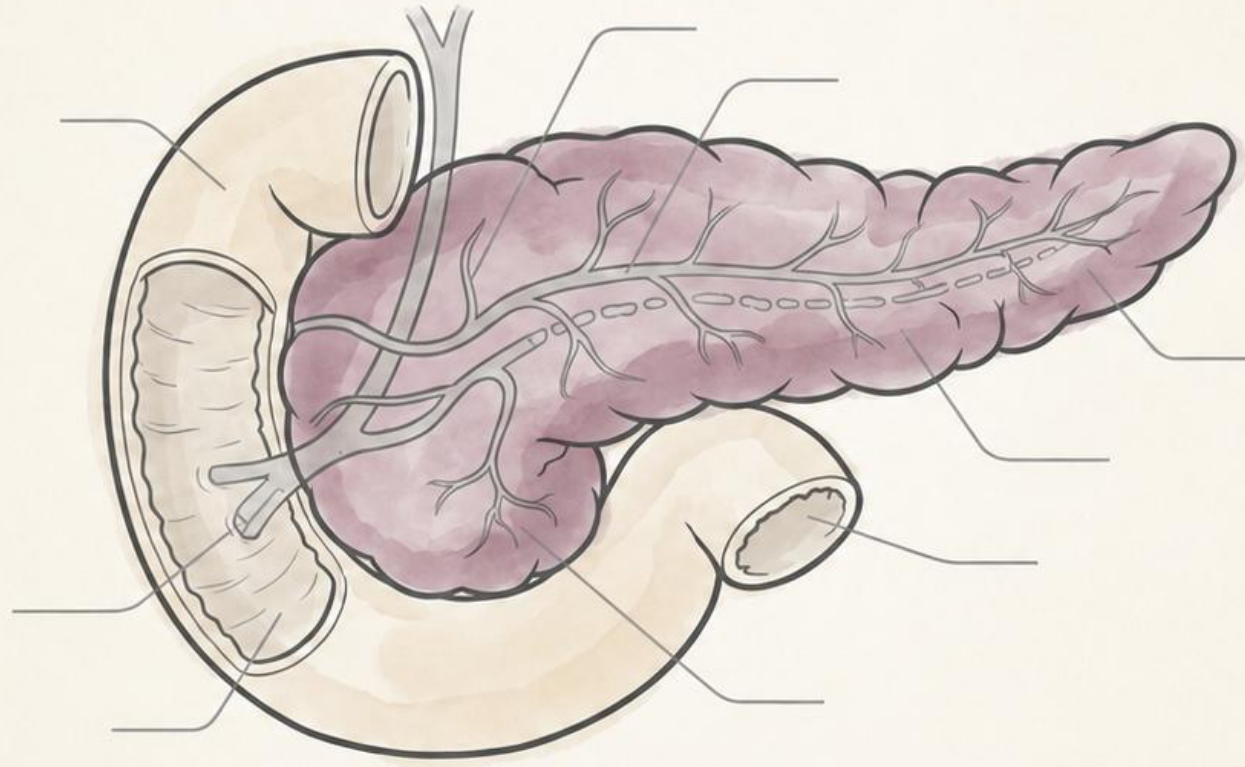


Le Pancréas

Anatomie, Physiologie et Réflexologie Occipito-Podale (ROP)



La Dualité Fonctionnelle du Pancréas

Pancréas Exocrine (95% du tissu)

- Sécrétion : Suc pancréatique (1,5 à 2 L / jour)
- Cible anatomique : Duodénum
- Rôle physiologique : Digestion (neutralisation acide et clivage enzymatique)

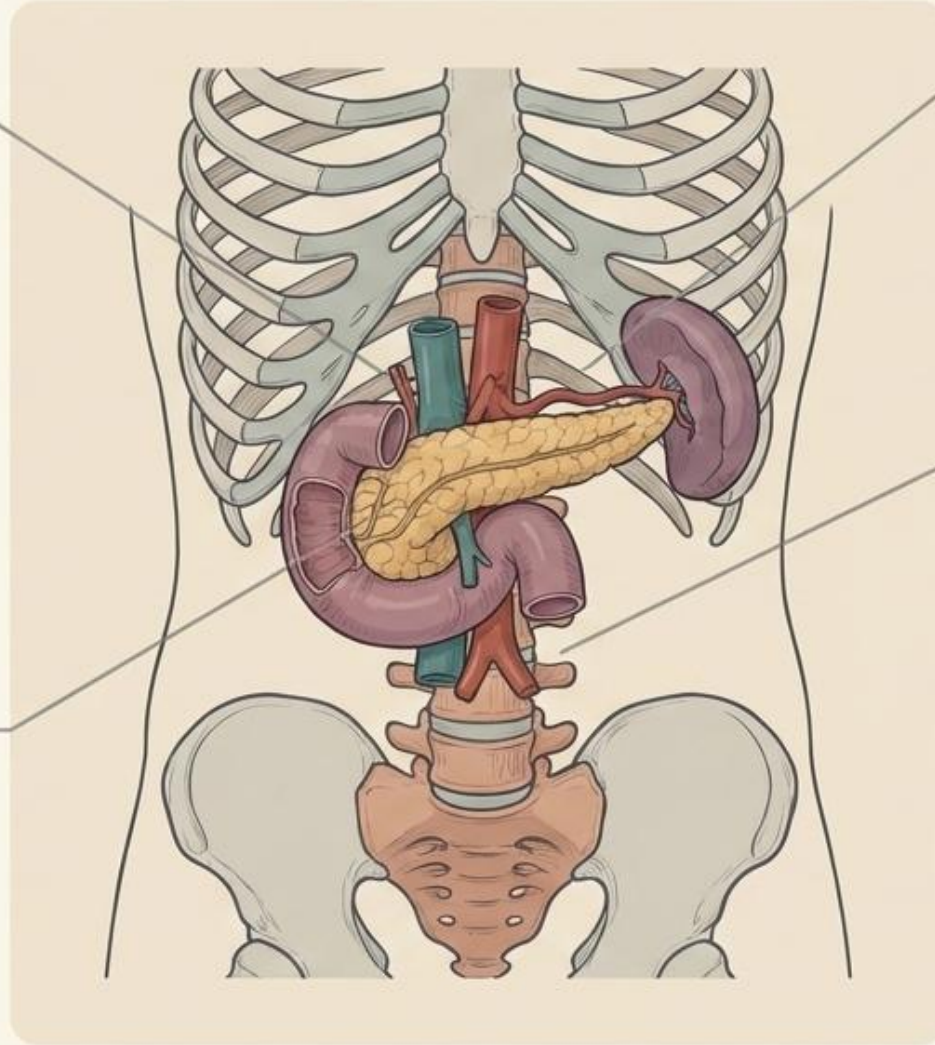
Pancréas Endocrine (5% du tissu)

- Sécrétion : Hormones (Insuline, Glucagon, Somatostatine)
- Cible anatomique : Sang (circulation systémique)
- Rôle physiologique : Équilibre de la glycémie (homéostasie)

Un Organe Profond et Vulnérable

Situation Centrale
Sous-diaphragmatique et rétro-péritonéal. S'étend du cadre duodénal à la rate.

Mensurations
16 à 20 cm de long, ~2,5 cm d'épaisseur, ~80 g.

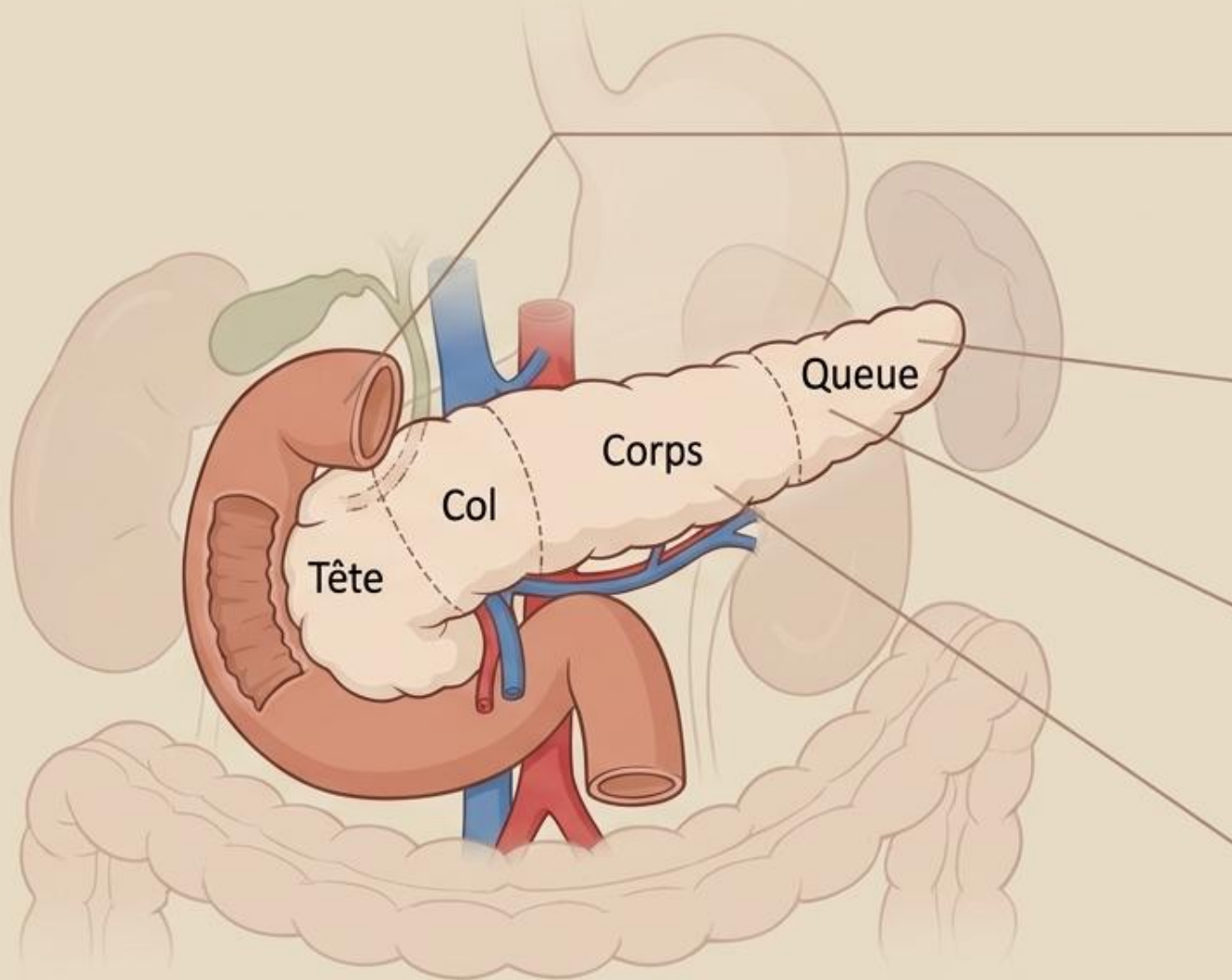


Repères Topographiques
Bord inférieur à 4 travers de doigt au-dessus de l'ombilic. Bord supérieur sous le 7^e/8^e cartilage costal gauche.

Vulnérabilité Traumatique
Organe friable. Vulnérable lors de chocs directs ou chutes à plat ventre en raison du plan vertébral postérieur.

Morphologie Anatomique

De l'ancrage duodénal à la mobilité splénique



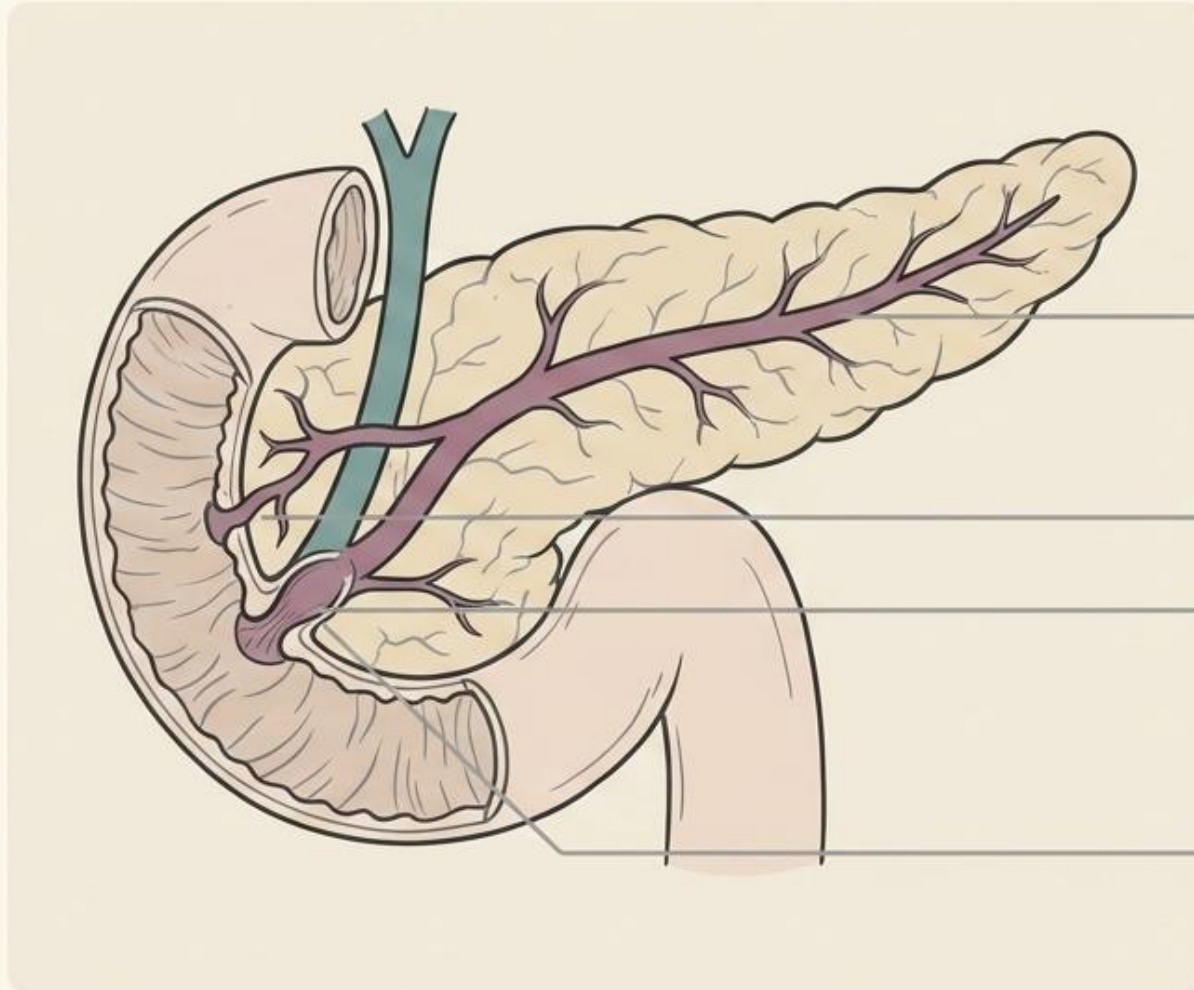
Tête & Processus uncinatus : Enchâssée dans le cadre duodénal. Analogie mécanique : la tête est la jante, le duodénum est le pneu. Fixation forte.

Col : Relie la tête au corps. Face dorsale en rapport avec le cholédoque, face ventrale adjacente au pylore.

Corps : En avant de l'aorte (L2-L3). Zone de haute vulnérabilité.

Queue : Partie la plus mobile. En rapport avec le rein gauche, le hile de la rate et l'angle splénique du côlon.

Le Réseau Canalaire Exocrine



Canal de Wirsung (Principal)

Parcourt le pancréas de la queue vers la tête.



Canal de Santorini (Accessoire)

Se sépare du Wirsung au niveau de la tête et s'ouvre par la papille duodénale mineure.



L'Ampoule de Vater

Le Wirsung rejoint le cholédoque pour déboucher dans l'ampoule hépato-pancréatique (grande caroncule).



Sphincter d'Oddi

Valve musculaire contrôlant l'ouverture de l'ampoule de Vater. Point clé en traitement ROP.

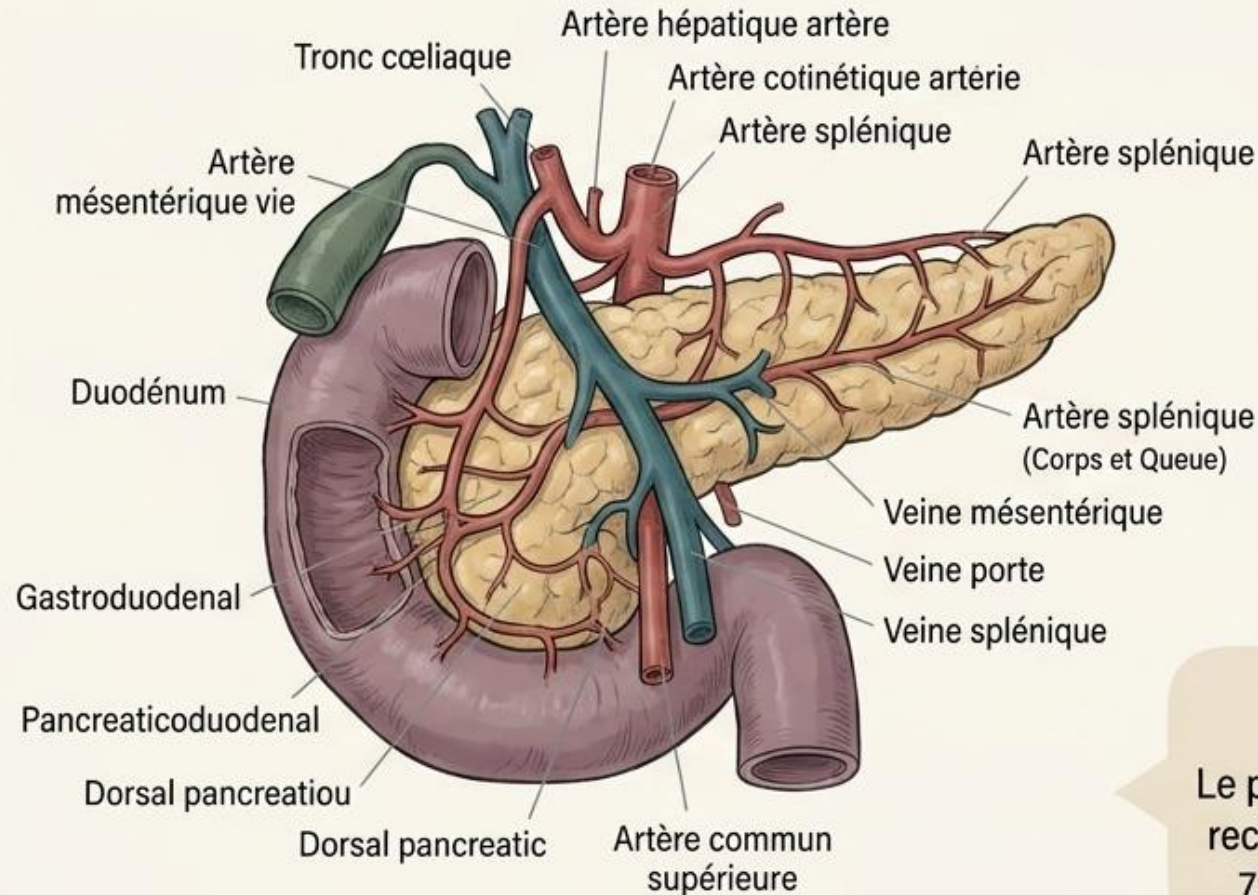
Un Écosystème Vasculaire Partagé

Le système vasculaire pancréatique est en stricte continuité avec le foie, le duodénum et la rate, témoignant de liens physiologiques étroits.

Réseau Artériel

Tronc cœliaque → Artère hépatique commune / Artère mésentérique supérieure (Tête).

Artère splénique (Corps et Queue).



Réseau Veineux

Retour assuré par le système porte (veine mésentérique supérieure + veine splénique).

Repère Clinique

Le pouls de l'artère splénique peut être recherché à 3 travers de doigt sous le 7^{ème}/8^{ème} cartilage costal gauche.

Innervation et Commande Neurovégétative

Système Parasymphique (Nerf Vague X)

Stimule et participe à la régulation neurovégétative des sécrétions digestives et pancréatiques. Cible prioritaire en ROP pour synchroniser la digestion.

Réseau Périphérique

En rapport direct avec le plexus coeliaque et le plexus mésentérique supérieur.



Système Sympathique (Étage Thoracique)

Commande sympathique rapportée aux étages médullaires thoraciques moyens (Th8-Th10 gauches).

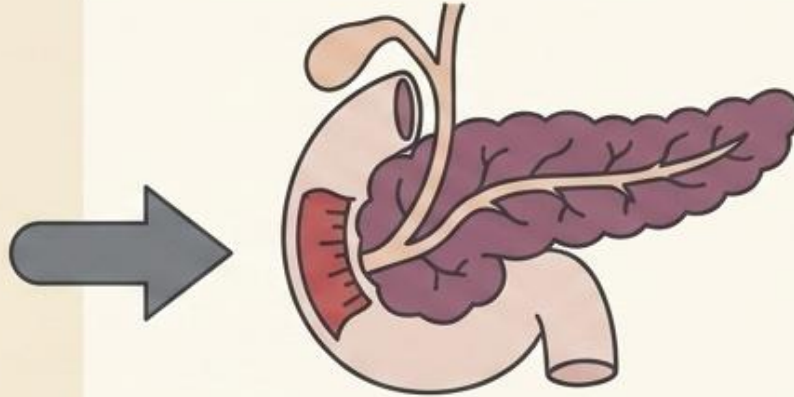
Intérêt en ROP

Le travail manuel sur le pancréas implique de solliciter simultanément les organes partageant ces mêmes rapports vasculo-nerveux (duodénum, foie, rate).

Physiologie Exocrine : La Machine Digestive

Déclencheurs Physiologiques

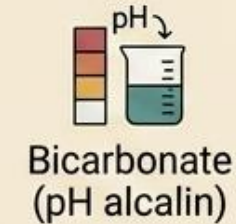
- Remplissage de l'estomac
- Activité du nerf vague
- Sécrétine (neutralisation)
- Cholécystokinine (CCK)



Volume

Représente 95% du tissu
pancréatique. Produit 1,5 à 2 litres
de suc pancréatique par 24h.

Composition & Action



Bicarbonate
(pH alcalin)

→ Neutralise l'acidité
gastrique.



Amylase

→ Digestion de
l'amidon.



Chymotrypsine

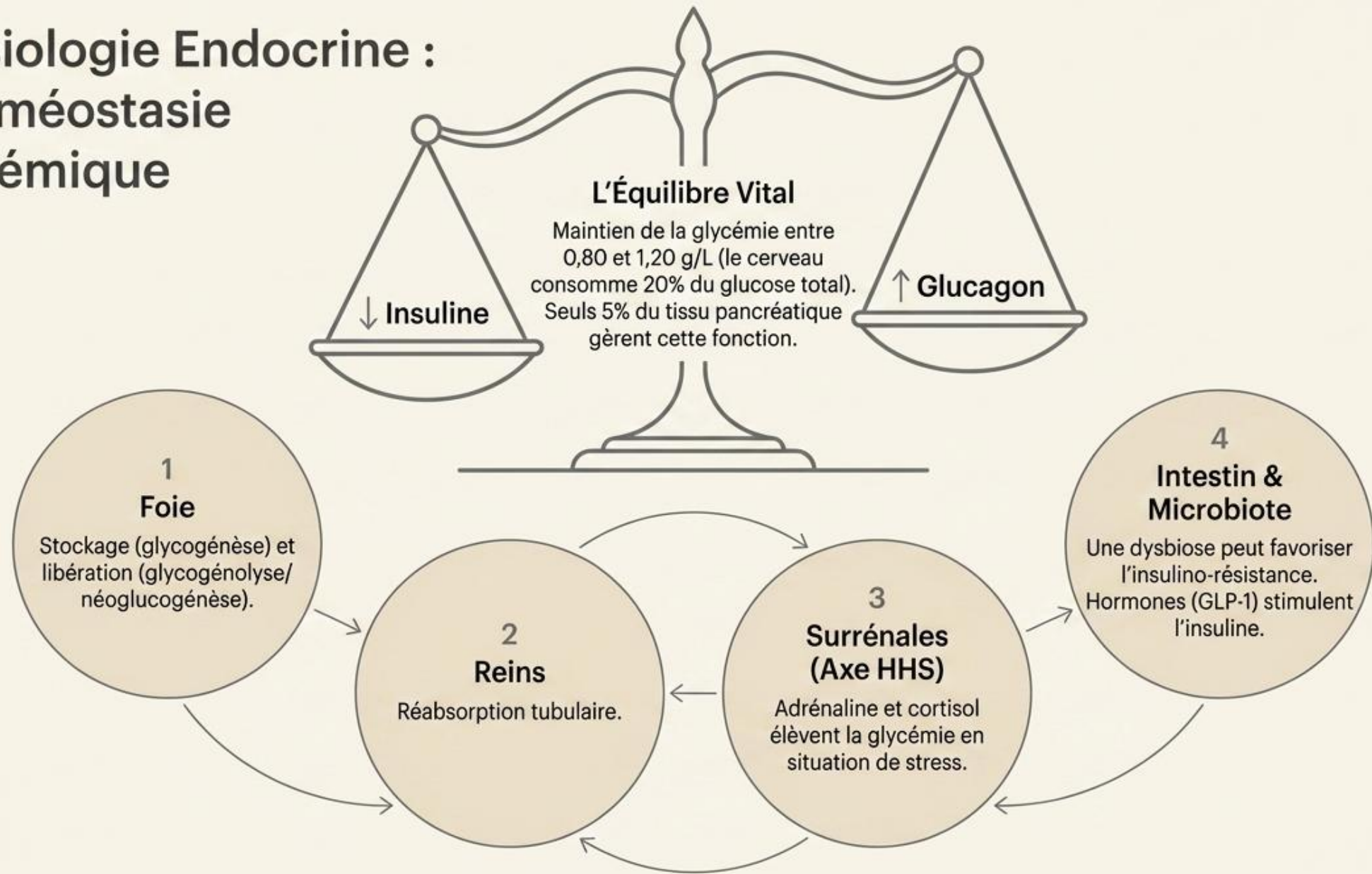
→ Protéines
(trypsinogène activé
dans le duodénum
pour éviter
l'autodigestion).



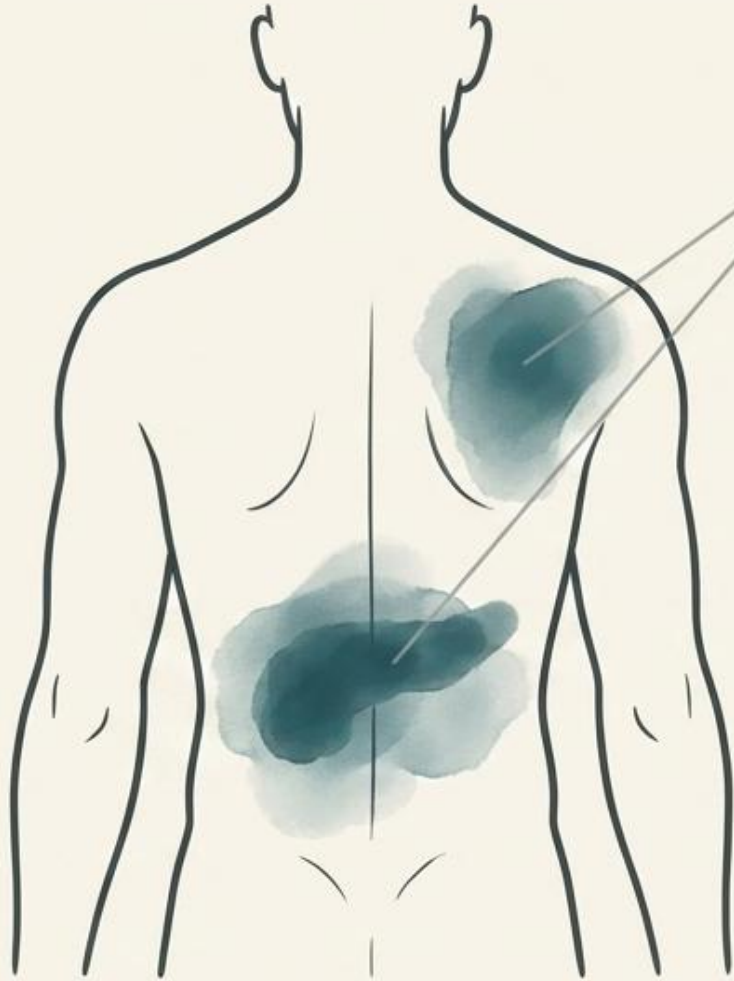
Lipase

→ Lipides (glycérol,
acides gras).

Physiologie Endocrine : L'Homéostasie Glycémique



Manifestations Cliniques et Diagnostics d'Exclusion



L'illusion Articulare

Le pancréas peut se manifester initialement par des douleurs d'apparence mécanique : lombalgie haute aiguë (L2), dorsalgie basse, lumbago ou scapulalgie gauche.

Drapeaux Rouges (Signes d'Alerte)

- Douleur épigastrique transfixiante, irradiant dans le dos, surtout nocturne.
- Amaigrissement important, involontaire.
- Selles flottantes, grasses, luisantes, couleur mastic.
- Satiété précoce suivie d'une fringale (sucre/gras) une heure après.
- Fatigue extrême, prurit, polyurie, soif intense.

Pathologies Glycémiques : Le Spectre du Diabète



Diabète de Type 1 (Insulino-dépendant)

Origine auto-immune.
Apparition dans
l'enfance/adolescence.
Terrain génétique de
susceptibilité.



Diabète de Type 2 (Insulino-résistant)

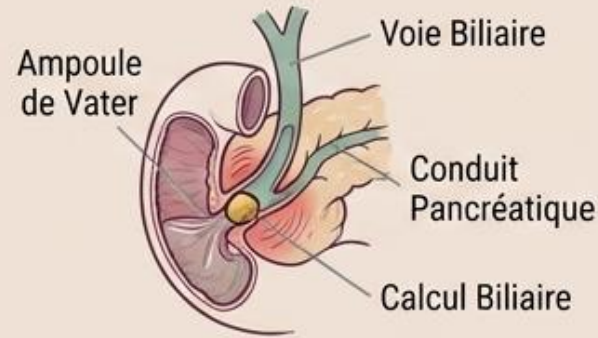
Lié à l'obésité, la sédentarité et
aux facteurs métaboliques de
l'adulte.



Diabète Gestationnel

Apparaît au 2e/3e trimestre.
Baisse de la sensibilité à
l'insuline. Le glucose traverse la
barrière placentaire (risque de
macrosomie fœtale et
complications néonatales).

Pathologies Sévères : Pancréatites et Tumeurs



Pancréatite (Inflammation)

- **Lithiase biliaire** : Un calcul se bloque dans l'ampoule de Vater, obstruant les voies biliaires et pancréatiques.
- **Origine toxique** : L'alcool est une cause majeure.
- **Traumatique** : Suite à un choc abdominal ou chirurgie biliaire.



Cancer du Pancréas (Adénocarcinome)

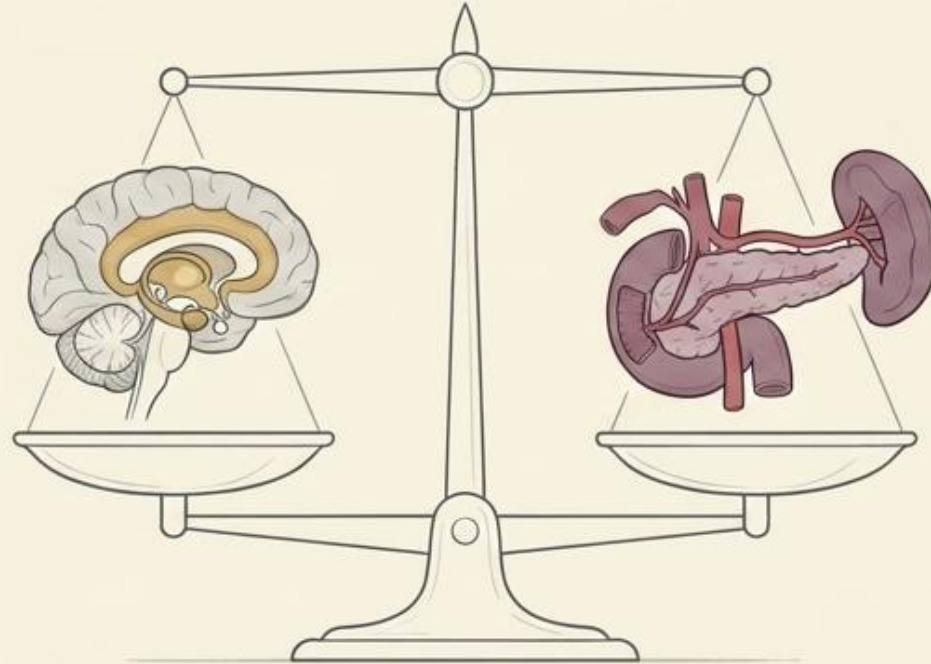
- **Pronostic sombre** car souvent silencieux (les symptômes apparaissent à un stade avancé).
- Douleur dorsolombaire inhabituelle peut être un signe révélateur.
- **Facteurs de risque** : Tabac (établi), alcool et contextes métaboliques (discutés).

Synthèse Viscéro-Émotionnelle

Balance cerveau limbique-pancréas (écoute-induction : un pouce sur le pancréas, l'autre sur le cerveau limbique).
Sur le plan émotionnel, Pancréas et Rate sont indissociables.

Stress Émotionnels :

- Réaction aux stress impossibles à intégrer (injustice, ruptures affectives).
- Deuils non acceptés (ex: perte d'un enfant).
- Enfance meurtrie, volée, ou confrontation à la violence.



Profil Clinique :

Le patient au profil Pancréas/Rate se présente souvent comme triste, pessimiste, et vidé de son énergie face aux agressions psycho-émotionnelles.

La ROP accompagne fonctionnellement la digestion et l'homéostasie, mais ne remplace jamais un traitement médical (ex: insuline).